

Symptômes semaine par semaine en grossesse (Semaines 1-40)

Semaine	Symptômes normaux fréquents	Symptômes pouvant indiquer une complication (signes d'alerte)
1	Aucun symptôme perceptible (pas de nausées, fatigue ou boule au ventre marqués) – on ne remarque généralement rien au niveau corporel ¹ . Au mieux, seins légèrement tendus, quelques pertes vaginales blanches ou crampes très légères peuvent survenir.	Tout saignement vaginal (surtout rouge vif abondant), douleur pelvienne aiguë ou fièvre élevée doivent alerter immédiatement (risque de fausse couche ou de grossesse extra-utérine) ² .
2	Aucun signe évident non plus – votre grossesse est encore très précoce. Seules anomalies possibles : léger retard de règle ou quelques saignements très faibles (nidation), fatigue ou besoin de dormir plus qu'à l'habitude ³ .	Saignements vaginaux abondants ou persistants, douleurs abdominales sévères ou fièvre anormale sont alarmants ⁴ .
3	Fatigue inhabituelle et somnolence diurne; seins tendus et sensibles; nausées matinales légères (éventuellement nausées vertes sans vomissements); tiraillements faibles dans le bas-ventre; appétit en hausse et envies d'uriner fréquentes ⁵ ⁶ .	Douleurs basses-ventre violentes ou augmentant, et saignements vaginaux importants (rouge vif) sont inquiétants, évoquant une menace de fausse couche ou d'ectopique ⁷ .
4	Très grande fatigue, malaises vagues possibles (faiblesse, vertiges); nausées (envie de vomir) persistantes; douleurs légères aux seins; somnolence diurne; aversions alimentaires. Seins très tendus, utérus qui tire (légers tiraillements bas-ventre) et envies très fréquentes d'uriner sont fréquents ⁸ ⁹ .	Tout saignement vaginal ou toute douleur bas-ventre qui durent doit être signalé au médecin (risque de fausse couche) ¹⁰ .
5	Envie permanente de dormir, malaise général, tachycardie bénigne; envies fréquentes d'uriner; hypersensibilité émotionnelle; nausées et vomissements modérés peuvent persister; reflux gastro-œsophagien (brûlures d'estomac) et constipation sont fréquents ¹¹ ¹² .	Douleurs bas-ventre intenses et pertes vaginales foncées ou sanglantes qui s'intensifient (au lieu des légères pertes brunes habituelles) doivent inciter à consulter en urgence (fausse couche possible) ¹³ .
6	Nouvelles nausées matinales, fatigue encore marquée; lombalgies légères, tiraillements ligamentaires bas-ventre; prise de poids très modérée (parfois un peu plus de seins) ¹⁴ ¹⁵ .	Saignements vaginaux (rouge vif), douleurs abdominales très fortes ou fièvre élevée sont anormaux (évoquent fausse couche ou infection).

Semaine	Symptômes normaux fréquents	Symptômes pouvant indiquer une complication (signes d'alerte)
7	Envies d'uriner très fréquentes; légère dyspnée (essoufflement) à l'effort; nausées persistantes; constipation; faibles douleurs ligamentaires pelviennes; jambes lourdes, veines apparentes (varices débutantes); seins plus volumineux; fatigue chronique ¹⁶ .	Pertes vaginales anormales (odeur nauséabonde, coloration verdâtre/rouge) ou saignements importants doivent alerter (risque infection ou complication obstétricale) ¹⁷ .
8	Migraines hormonales possibles; nausées matinales modérées; grande fatigue; sautes d'humeur; acné de grossesse possible; troubles digestifs (diarrhée ou constipation) ; essoufflement lors d'efforts ¹⁸ ¹⁹ .	Tout saignement vaginal, douleur abdominale sévère ou fièvre persistante doit être évalué.
9	Grande fatigue; oppression thoracique/ essoufflement (utérus en expansion) ; envies d'uriner fréquentes ; crampes abdominales légères (tiraillements utérins) ; nausées et vertiges s'amenuisent progressivement ²⁰ .	Douleur pelvienne lancinante ou augmentation des pertes vaginales (sanguines) doivent inquiéter, pouvant signaler un problème utérin ²¹ .
10	Disparition progressive des nausées matinales et des vertiges; reprise de l'appétit, libido en hausse; envies d'uriner moins fréquentes qu'avant; amélioration de l'humeur générale ²² .	Écoulement vaginal suspect (coloré ou malodorant) – souvent signe d'infection – justifie une consultation ²³ .
11	Ventre légèrement plus rond et prise de poids modérée ; appétit très actif, sensation de faim continue; essoufflement passager et accélération cardiaque dues à la volumétrie sanguine ; rares tiraillements bas-ventre subsistent moins fréquemment ²⁴ ²⁵ .	Saignement vaginal ou douleur violente (comme de l'« éclatement » du bas ventre), tout comme fièvre, doivent être rapportés (risques : fausse couche tardive ou autres complications).
12	Fatigue quasi-permanente, douleurs articulaires (bas du dos, articulations pelviennes) liées à l'élargissement de l'utérus ; tiraillements utérins bas-ventre ; seins volumineux et douloureux (hormones) ; épisodes de bouffées de chaleur, sautes d'humeur, démangeaisons abdominales (peau étirée) ²⁶ ²⁷ .	Pertes vaginales anormales (colorées/odorantes) ou douleur abdominale très forte doivent alerter (infection ou complication placentaire).
13	Disparition quasi-totale des nausées, regain d'énergie notable ; appétit très accru (envies persistantes de manger) ; libido réactivée, teint éclatant ; quelques brûlures d'estomac occasionnelles dues à la pression utérine ²⁸ ²⁹ .	Tout saignement vaginal, douleur aiguë constante ou fièvre de plus de 38 °C restent alarmants.

Semaine	Symptômes normaux fréquents	Symptômes pouvant indiquer une complication (signes d'alerte)
14	(2 ^e trimestre début) Ventre nettement plus arrondi, prise de poids régulière ; apparition éventuelle de vergetures abdominales ; pigmentation foncée (ligne brune verticale sur le ventre) ³⁰ . Seins prennent du volume et émettent parfois du colostrum ³¹ . Énergie accrue, humeur stable, premiers mouvements fœtaux ressentis vers 18–20 SA ³² .	Contractions régulières ou violentes prématurées, saignements vaginaux marqués, céphalées intenses ou troubles visuels (prééclampsie) sont des signes d'alerte.
15	Gros appétit, remontée partielle des nausées ; brûlures d'estomac plus fréquentes ; douleur ligamentaire inguinale ou pubienne en cas de mouvements brusques ; varices débutantes ou hémorroïdes plus fréquentes ; gencives gonflées ou saignantes. Libido conservée, meilleure énergie générale.	Douleurs épigastriques intenses, céphalées persistantes, fièvre élevée, ou saignement vaginal continu nécessitent consultation.
16	Prise de poids continue, tiraillements bas-ventre (ligaments élargis) ; éternuements ou efforts pouvant entraîner de petites fuites urinaires ; mamelons plus proéminents, sécrétion de colostrum possible (petites taches jaunes) ; constipation, ballonnements fréquents.	Absence de mouvements fœtaux ressentis (après 20 SA) ou augmentation rapide des pertes vaginales (liquide clair => début de rupture des membranes) sont alarmants.
17	Premières sensations des mouvements fœtaux (« coups dans le ventre ») si ce n'était déjà fait ³² ; hanches et bassin prennent plus d'ampleur ; varices (jambes, poitrine) visibles ; gencives sensibles (saignement lors du brossage) ³³ ; teint de grossesse éclatant, cheveux brillants.	Si les mouvements du bébé sont nettement diminués ou absents, ou si des contractions de travail surviennent précocement, consultez.
18	Fœtus très actif (coups perceptibles) ; lombalgies et douleurs sciatiques fréquentes ; congestion nasale, saignements de nez possibles (muqueuses enflées) ; reflux gastrique fort (on se redresse après les repas) ; apparition de la ligne nigra plus visible ; vergetures dorsales ou thoraciques possibles.	Fièvre prolongée, frissons, douleurs lombaires intenses, ou perte incontrôlable de liquide amniotique (baguette qui se rompt) nécessitent évaluation en urgence.
19	Courbatures, crampes musculaires (mollets la nuit) ; tensions ligamentaires dans l'aine ; insomnie possible ; mouvements fœtaux marqués (bébé griffe le bord interne des côtes) ; appétit encore élevé, fringales fréquentes ; apparence du masque de grossesse plus prononcée.	Contractions régulières (rythme horaire rapproché), douleurs continues dans le bas-ventre, ou diminution nette des mouvements fœtaux sont des signaux d'alerte.

Semaine	Symptômes normaux fréquents	Symptômes pouvant indiquer une complication (signes d'alerte)
20	Mi-parcours : ventre bien rond, prise de poids cumulée 4-7 kg ; production occasionnelle de colostrum (tâches jaunâtres sur le soutien-gorge) ³¹ ; vergetures prononcées (ventre/cuisses) ; sautes d'humeur rares, libido équilibrée.	Douleur épigastrique intense, céphalées violentes, œdème facial soudain ou hypertension sévère (prééclampsie), ou saignements vaginaux abondants nécessitent consultation immédiate ³⁴ .
21	Hypertrophie de l'utérus (remontée dans l'abdomen) : respiration un peu plus courte, surtout en position allongée ; congestion nasale/eczéma de grossesse possible ; engourdissements dans les mains (syndrome du canal carpien) ; mouvements fœtaux fréquemment ressentis en jour/nuit.	Œdème généralisé (visage, mains) avec céphalées, douleurs abdominales sévères ou fièvre élevée (infection) justifient un avis médical rapide ³⁴ .
22	Contractions de Braxton Hicks occasionnelles (petits durcissements utérins irréguliers) ³⁵ ; gonflement des chevilles/jambes accru (rétention d'eau) ; transpiration aisée (bouffées de chaleur, nuits chaudes) ; engouement pour la préparation de la chambre (« nesting instinct »).	Troubles visuels soudains, céphalées intenses et vomissements, ou contraction continue très douloureuse (travail prématuré imminent) doivent amener aux urgences.
23	Perte du bouchon muqueux pouvant survenir ; contraction utérine forte lors d'efforts (contractions souvent indolores) ; démangeaisons abdominales plus marquées ; sommeil perturbé (insomnies, cauchemars) ; fatigue prononcée.	Tout saignement post-terme, odeur fétide des pertes vaginales ou fièvre (infection) est anormal.
24	Essoufflement important (utérus à 24-26 cm de hauteur) ; reflux gastrique chronique (brûlures) ; brûlures d'estomac fréquentes ; accoutumance posée (bronzes peuvent être plus prononcés).	Contractions régulières douloureuses (de plus en plus rapprochées) ou perte de liquide claire abondante indiquant rupture de poche des eaux nécessitent consultation obstétricale.
25	Œdème (visage, mains, chevilles) souvent prononcé au réveil ; insomnie marquée (toutes positions deviennent inconfortables) ; douleur bas-ventre (ligaments arrondis) plus fréquente ; douleur dorsale intermittente ; tension dans les jambes (crampes nocturnes).	Si absence nette de mouvements du bébé, variations importantes de tension ou fièvre $\geq 38^{\circ}\text{C}$, contacter immédiatement.
26	Coups du bébé fréquents et parfois douloureux ; augmentation du volume des seins, colostrum en quantité ; des jambes lourdes et veines apparentes (varices) ; miction fréquente nocturne ; apparition possible d'hémorroïdes ou congestions pelviennes.	Contractions intenses très rapprochées avant 37 SA, douleur thoracique soudaines ou marée de liquides verres/verts (méconium) signalent un problème.

Semaine	Symptômes normaux fréquents	Symptômes pouvant indiquer une complication (signes d'alerte)
27	(3 ^e trimestre début) Œdème des pieds/chevilles marqué (rétention d'eau) ³⁶ ; essoufflement à l'effort ³⁷ ; contractions de Braxton-Hicks plus fréquentes ; démangeaisons cutanées (ventre tendu) ; gencives sensibles.	Si les membranes se rompent (écoulement chaud/clair), contractions régulières ou saignement sanguinolent, se rendre d'urgence à l'hôpital.
28	Grossesse à terme proche : essoufflement majeur, pression sur le périnée (bébé descendu), reprise partielle du confort respiratoire ; brûlures d'estomac intenses ; œdème en augmentation (mains, visage); contraction utérine involontaire au moindre effort.	Toute perte de liquide amniotique teintée ou toute contraction régulière active (générées toutes les 5 minutes), ainsi que maux de tête persistants, doivent mener aux urgences.
29	Activité du bébé très perceptible (petits coups sur l'estomac) ; respiration souvent courte ; conservation des brûlures gastriques ; jambes très enflées, lourdeur du dos ; finalisation de la préparation psychologique à l'accouchement.	Contractions de travail douloureuses régulières, fièvre élevée ou céphalées et vision trouble (prééclampsie) sont des signes d'alerte majeurs.
30	Essoufflement marqué, premiers fuites urinaires ou pertes de glaire (« leak ») lors de toux/éternuements ; crampes jambes fréquentes ; troubles du sommeil extrêmes ; oedème généralisé (poignets, chevilles) ; démangeaisons intenses.	Nausées/vomissements sévères, importantes maux de tête persistants ou absence de mouvements actifs du bébé justifient un contrôle médical.
31	Contractions de Braxton-Hicks fréquentes (contractions « d'entraînement ») ; abdomen dur temporairement ; élargissement du bassin plus sensible (douleurs pubiennes) ; perte encore plus marquée d'appétit (satisfait rapidement).	Tout saignement rouge vif, douleur abdominale aiguë « en barre » ou signe de fonte du liquide amniotique (sensation de « pipi chaud ») nécessite hospitalisation.
32	Réelles contractions d'entraînement (plus fortes) ³⁵ ; sommeil très perturbé ; épistaxis plus fréquents ; brûlures d'estomac quotidiennes ; œdème permanent (pieds/chevilles enflés).	Contractions très régulières rapprochées (travail actif) ou diminution considérable des mouvements fœtaux doivent conduire aux urgences.
33	Bébé souvent tête en bas (tête engagée), lourdeur pelvienne intense ; remontée acide permanente ; grandes fatigues ; engagement du bassin (younger-baby); pertes vaginales saumâtre (« écoulement du bouchon »).	Fièvre inexpliquée, gencives très enflées/saignantes, ou perturbation visuelle (points lumineux, cécité) sont alarmants.

Semaine	Symptômes normaux fréquents	Symptômes pouvant indiquer une complication (signes d'alerte)
34	Œdème généralisé très marqué (inclus mains et visage le matin) ; son bébé ajuste son rythme (réveil plus nocturne) ; sensibilité accrue (peau très sèche, tiraillements) ; diminution du retour veineux (fourmillements des pieds) ; hypersialorrhée possible.	Douleur intense en barre épigastrique (prééclampsie), mouvements fœtaux quasi absents, ou liquide rompu (répétition : écoulement chaud et continu) exigent un soin immédiat.
35	Bébé très bas (sent descendre la tête) – le ventre « s'allège » ; contractions Braxton un peu plus fortes, lombalgies intenses ; grandes fluctuations d'humeur ; plus grand confort respiratoire (bébé moins appuyé sur le diaphragme).	Début de vrais contractions de travail (rythme régulier croissant), perte de liquide clair continue, ou saignement vaginal rouge important sont des urgences.
36	Contractions utérines de plus en plus intenses et rapprochées (préparation au travail) ; pression sur le périnée/tronc pelvien ; constipation persistante ; vessie très comprimée (besoin d'uriner quasiment constant) ; fatigue extrême ; insomnie majeure.	Toute douleur dorsale ou abdo irréductible, céphalée avec nausées/vomissements, ou gonflement rapide du visage/ mains (prééclampsie) est extrêmement préoccupant.
37	Bébé considéré à terme (tête engagée, foie du bébé prêt) : parfois légères nausées matinales résiduelles ; fourmillements/pulsations dans les jambes dues à la pression ; contractions de Braxton douloureuses plus fréquentes ; perte du bouchon muqueux possible (glaise teintée de sang).	Contractions régulières rapprochées intensives (travail établi) ou liquide amniotique vert/sanglant sont des signaux clairs pour appeler le médecin.
38	Colostrum peut couler régulièrement des mamelons ; lourdeur extrême du bassin ; sensations de « mal aux reins » ; insomnies majeures ; agitation fœtale, puis moments de calme (bébé "prend sa place" dans le bassin).	Si travail prématuré vraiment démarre (contractions régulières, douleurs pelviennes) ou écoulement anormal rouge/verdâtre, consulter sans délai.
39	Fatigue et anxiété intenses ; mouvements du bébé moins amples (espace réduit) mais spasmodiques ; perte du bouchon muqueux parfois le jour précédent le travail ; descentes et pressions récurrentes sur le périnée ; jambes/le dos lourds.	Poche des eaux qui se rompt (écoulement continu de liquide), contractions espacées (3-5 min) de plus en plus douloureuses ou saignement important justifient appel aux urgences obstétricales.
40	Attente finale : jambes, dos et ventre très douloureux ; bébé « ressorti » dans le bassin (sensation de puits) ; insomnie complète ; pertes glaireuses de couleur rose (« bouchon muqueux ») ; accentuation du ballonnement abdominal.	Tout saignement soudain, contractions régulières intenses ou absence de toute perception des mouvements fœtaux sont des urgences absolues (appeler le médecin ou se rendre à l'hôpital).

Sources : Conseils tirés des guides de grossesse et des sites spécialisés (AlloBébé, Naitre et grandir, Pampers, etc.), validés par des professionnels de santé ¹ ³⁴ . Les symptômes normaux sont indiqués semaine par semaine ; tout symptôme d'alerte doit conduire à une consultation (liste résumée ³⁴).

¹ 1ère semaine de grossesse : début de l'aventure !

<https://www.allobebe.fr/semaine-grossesse-1.html>

² ³⁴ Problèmes durant la grossesse: les signaux d'alarme

<https://naitreetgrandir.com/fr/grossesse/sante-bien-etre/grossesse-problemes-signaux-alarmer/>

³ ⁴ 2ème semaine de grossesse : changement de vie !

<https://www.allobebe.fr/semaine-grossesse-2.html>

⁵ ⁶ ⁷ 3ème semaine de grossesse : les premiers signes !

<https://www.allobebe.fr/semaine-grossesse-3.html?srsltid=AfmBOorYRndx7JMr0EgchSIP46y8FF7tOE6qnLfUpBVhgZCkWAIXhy2s>

⁸ ¹⁰ 4ème semaine de grossesse : fatigue et sautes d'humeur !

<https://www.allobebe.fr/semaine-grossesse-4.html>

⁹ 4 semaines de grossesse (6 SA) : écho, quels symptômes ?

<https://www.journaldesfemmes.fr/maman/guide-grossesse/1348710-4-semaines-de-grossesse-6-sa/>

¹¹ ¹² ¹³ 5ème semaine de grossesse : fortes nausées et fatigue !

<https://www.allobebe.fr/semaine-grossesse-5.html>

¹⁴ ¹⁵ 6 semaines de grossesse (8 SA) : à quoi s'attendre | Pampers FR

<https://www.pampers.fr/grossesse/calendrier-de-grossesse/6-semaines-de-grossesse>

¹⁶ ¹⁷ 7ème semaine de grossesse : on s'habitue aux symptômes !

<https://www.allobebe.fr/semaine-grossesse-7.html>

¹⁸ ¹⁹ 8 semaines de grossesse (10 SA) : symptômes et conseils | Pampers FR

<https://www.pampers.fr/grossesse/calendrier-de-grossesse/8-semaines-de-grossesse>

²⁰ ²¹ 9ème semaine de grossesse : le ventre s'arrondit !

<https://www.allobebe.fr/semaine-grossesse-9.html>

²² ²³ 10ème semaine de grossesse : 1er examen prénatal !

<https://www.allobebe.fr/semaine-grossesse-10.html>

²⁴ ²⁵ 11ème semaine de grossesse : la grande annonce !

<https://www.allobebe.fr/semaine-grossesse-11.html>

²⁶ ²⁷ 12ème semaine de grossesse : 1ère visite prénatale dernier délai !

<https://www.allobebe.fr/semaine-grossesse-12.html>

²⁸ ²⁹ La 13ème semaine de grossesse : un très bon appétit !

<https://www.allobebe.fr/semaine-grossesse-13.html>

³⁰ ³¹ ³² ³³ 2e trimestre: changements physiques et maux courants

<https://naitreetgrandir.com/fr/grossesse/trimestre2/grossesse-changements-physiques-maux-courants-courants-2e-trimestre/>

³⁵ ³⁶ ³⁷ Troisième trimestre : symptômes et développement du bébé | Pampers FR

<https://www.pampers.fr/grossesse/calendrier-de-grossesse/troisieme-trimestre>